RESEARCH REPORT / KNOWLEDGE BASE

องค์ความรู้และหลักสูตร การผดุงครรภ์ในประเทศไทย

การผดุงครรภ์สมัยใหม่ • การผดุงครรภ์ไทยและพื้นบ้าน • โรงเรียนพ่อแม่ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์: รวบรวมสิ่งที่ “หลักสูตรและสถานบริการเผยแพร่จริง” เปรียบเทียบกับ “แนวทางมาตรฐาน” แล้วแปลงเป็นโครงสร้าง Knowledge Base พร้อมข้อเสนอวิธีใช้ต่อ สำหรับการค้นคว้าและออกแบบระบบการเรียนรู้

ขอบเขตหลัก: ประเทศไทย | มาตรฐานประกอบ: WHO, UNICEF, ICM และ Cochrane

ตรวจสอบแหล่งสาธารณะ ณ วันที่ 2 8 ตุลาคม พ.ศ. 2569 (2026)

รายงานสังเคราะห์ ไม่ใช่เอกสารรับรองหลักสูตร ไม่ใช่คู่มือให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตทำคลอด และไม่ใช่คำแนะนำรักษาผู้ป่วยรายบุคคล

การอ่านรหัสอ้างอิง

รหัส 0 1 4 0 เชื่อมไปยังรายการต้นฉบับพร้อมลิงก์ท้ายเล่ม ข้อเสนอใหม่ของผู้จัดทำจะระบุว่า “ข้อเสนอ” เพื่อไม่ปะปนกับหลักสูตรที่มีอยู่จริง

สรุปสำหรับอ่านก่อน (Executive summary)

การผดุงครรภ์ไม่ใช่ “การทำคลอดอย่างเดียว” แต่เป็นกระบวนการดูแลแม่ ทารก และครอบครัวตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด รวมทั้งการค้นหาความเสี่ยง การสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ และการส่งต่ออย่างเหมาะสม [S01–S06]

1. มี 3 กลุ่มผู้เรียนที่ต้องแยก: ผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้หลักสูตรและใบอนุญาต; บุคลากรที่อบรมเพิ่มสมรรถนะ; และพ่อแม่ที่เรียนเพื่อดูแลตนเอง ไม่ได้สิทธิทำคลอด
2. แนวทางสมัยใหม่เน้น Woman-centred care, การรักษาความปลอดภัยและเคารพทางเลือก, การดูแลต่อเนื่อง, หลักฐานเชิงประจักษ์ และการประสานทีม [S01–S08]
3. การผดุงครรภ์ไทยมีฐานกฎหมายและหลักสูตรของตนเอง: พบทั้งวิชาในปริญญาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร และอบรม 6 2 ชั่วโมงสำหรับพยาบาล [S15–S21]
4. หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่มีสื่ออ้างอิงจากกรมอนามัยและแบบอย่างในโรงพยาบาลจำนวนมาก แต่รายละเอียดแต่ละแห่งต่างกัน [S24–S33]
5. ความปลอดภัยต้องมาก่อน: ภาวะฉุกเฉิน อาการผิดปกติ ยา สมุนไพร และหัตถการ ต้องถูกคัดแยกตามขอบเขตวิชาชีพและมีระบบส่งต่อ [S06,S20,S23,S36]
6. “มีเอกสารหลักสูตร” ไม่เท่ากับ “กำลังเปิดรับสมัคร”; “โรงพยาบาลสอนเนื้อหา WHO” ไม่เท่ากับ “WHO รับรองโรงพยาบาล”

ภาพรวม 3 คำถามที่รายงานตอบ

โจทย์	สิ่งที่ได้จากรายงาน
1. สมัยใหม่และพื้นบ้าน	เปรียบเทียบองค์ความรู้ แนวทางที่เป็นหลักฐาน กฎหมาย ความปลอดภัย ข้อจำกัด
2. หลักสูตรปัจจุบัน	ตัวอย่างหลักสูตรจริงในไทย แบ่งตามระดับและกลุ่มผู้เรียน พร้อมสถานะหลักฐาน
3. โรงพยาบาลสอนพ่อแม่	กรณีศึกษาจริง 7 แห่ง + โครงสร้างเนื้อหากรมอนามัย + แยกการอ้างอิงกับการรับรอง

แนวทางใช้รายงานนี้

อ่านส่วน 1 2 เพื่อเข้าใจขอบเขตวิชาชีพ จากนั้นส่วน 3 -4 เพื่อดูตัวอย่างหลักสูตร ส่วน 5 6 สำหรับโรงเรียนพ่อแม่ และส่วน 7 8 เพื่อออกแบบ Knowledge Base/การเรียนรู้ที่ปลอดภัย

1 | คำจำกัดความและเส้นทางการเรียน

ประเภท	ใครเรียน / เพื่ออะไร	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
พยาบาลและผดุงครรภ์	ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและฝึกปฏิบัติวิชาชีพ	สถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ การสอบและใบอนุญาต [S09–S11]
บัณฑิตศึกษา/เฉพาะทาง	ผู้มีคุณสมบัติวิชาชีพเดิม เพิ่มความเชี่ยวชาญ	เงื่อนไขรับสมัคร คุณวุฒิเดิม และสมรรถนะหลังเรียน [S12–S14]
การผดุงครรภ์ไทย	ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติภายใต้ระบบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	ประเภทหลักสูตร ขอบเขตวิชาชีพ การขึ้นทะเบียน [S15–S21]
หมอตำแย/ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	การถ่ายทอดวัฒนธรรมและองค์ความรู้ชุมชน	การรับรองรายบุคคล ความปลอดภัย และระบบส่งต่อ; ไม่ถือเป็นวิชาชีพอัตโนมัติ
โรงเรียนพ่อแม่	หญิงตั้งครรภ์ คู่สมรส ผู้ดูแล	หัวข้อ ผู้สอน กิจกรรมฝึกปฏิบัติและวิธีติดตามผล [S24–S33]

ศัพท์สำคัญ

- ANC (Antenatal Care): การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์; “8 contacts” ของ WHO เป็นการติดต่อรับบริการสุขภาพ ไม่ใช่จำนวนคาบในคลาส [S03]
- Intrapartum: ช่วงเจ็บครรภ์และคลอด; Postpartum/Postnatal: หลังคลอดของมารดาและทารก [S04,S05]
- Continuity of care: การดูแลต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์คนเดิมหรือทีมขนาดเล็ก โดยประสานวิชาชีพอื่นเมื่อจำเป็น [S08]
- BFHI: Baby-friendly Hospital Initiative; กรอบ WHO/UNICEF เพื่อสนับสนุนการให้นมแม่ ไม่ใช่ใบรับรองสำหรับทุกคลาสเตรียมคลอด [S07]
- แนวทางคลินิก ≠ หลักสูตร ≠ ใบรับรองเข้าอบรม ≠ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

บทบาทและขอบเขตทางกฎหมาย

การประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมายและผู้อนุญาตของแต่ละระบบ: ฝั่งพยาบาล/ผดุงครรภ์ตรวจสภาการพยาบาล ส่วนการแพทย์แผนไทยตรวจข้อกำหนดของสภาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [S09–S11,S20,S21]

ข้อควรระวัง: รายงานไม่ได้ยืนยันว่า “หลักสูตร 6 2 ชั่วโมง” หรือ “การเข้าโรงเรียนพ่อแม่” ทำให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้น ผู้ใช้ต้องตรวจหลักเกณฑ์และใบอนุญาตจริงก่อนปฏิบัติงาน

2 | แผนที่องค์ความรู้ (Knowledge domains)

ข้อเสนอโครงสร้างสำหรับคลังข้อมูลกลาง: แบ่ง 12 หมวด แล้วกำหนดระดับสิทธิการเข้าถึง (ประชาชน/ผู้เรียนวิชาชีพ/ผู้มีใบอนุญาต) แยกกัน [S01–S07,S24–S26]

หมวด	สิ่งที่ควรตอบได้	ผู้เรียนเป้าหมาย
01 สิทธิและสื่อสาร	ความยินยอม ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว การตัดสินใจร่วม	ทุกกลุ่ม
02 ก่อนตั้งครรภ์	การเตรียมสุขภาพ วางแผนครอบครัว ประเมินความเสี่ยง	ทุกกลุ่ม
03 ANC	ติดตามครรภ์ โภชนาการ คัดกรอง ยา/วัคซีนโดยทีมรักษา	ทุกกลุ่ม
04 เตรียมคลอด	แผนคลอด ทางเลือก การเดินทาง การสนับสนุนจากคู่สมรส	พ่อแม่+บุคลากร
05 ระยะคลอด	เฝ้าระวังระยะคลอด การสื่อสาร ความปลอดภัย	บุคลากร; หัตถการจำกัดสิทธิ
06 หลังคลอด	การฟื้นตัว สุขภาพจิต อาการผิดปกติ การคุมกำเนิด	ทุกกลุ่ม
07 ทารกแรกเกิด	การกิน นอน สัมผัส สุขอนามัย การตรวจติดตาม	ทุกกลุ่ม
08 นมแม่	การสนับสนุนการเข้าเต้า รับมือปัญหา ช่องทางปรึกษา	ทุกกลุ่ม
09 ภาวะเสี่ยง	รู้สัญญาณอันตราย ความเร่งด่วนและการส่งต่อ	ทุกกลุ่ม—ระดับต่างกัน
10 ไทยและพื้นบ้าน	ที่มา คัมภีร์/วิถีปฏิบัติ หลักฐาน ข้อควรระวัง	ผู้เรียนแพทย์แผนไทย + ความรู้ทั่วไป
11 กฎหมาย/จริยธรรม	ขอบเขตวิชาชีพ ใบอนุญาต สิทธิผู้ป่วย	บุคลากรและผู้จัดหลักสูตร
12 วิจัย/ประเมินผล	ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ทักษะและผลการเรียน	ผู้จัดหลักสูตร/ผู้วิจัย

หลักการเขียนเนื้อหาแต่ละหัวข้อ: อธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ → มีเวอร์ชันสำหรับบุคลากร → ระบุขอบเขตหัตถการ → แสดงแหล่งอ้างอิงและปีฉบับเสมอ

3 | การผดุงครรภ์สมัยใหม่: แกนหลักฐาน

3.1 สมรรถนะของผดุงครรภ์

ICM Essential Competencies 2024 มี 5 หมวด ได้แก่ (1) สมรรถนะข้ามงาน (2) สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (3) การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ (4) การดูแลระหว่างเจ็บครรภ์และคลอด (5) การดูแลต่อเนื่องของสตรีและทารก โดยมุ่งผลลัพธ์ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ใช้จริง [S01,S02]

3.2 แนวทางตลอดวงจร

ช่วง	แกนเนื้อหาอิงมาตรฐาน	ข้อสังเกต
ระหว่างตั้งครรภ์	WHO 2016: รูปแบบอย่างน้อย 8 contacts พร้อมการประเมินและให้ข้อมูล	จำนวนครั้งบริการ ≠ จำนวนคาบโรงเรียนฟอแม่ [S03]
ระหว่างคลอด	WHO 2018: respectful, woman-centred care, สื่อสารชัด, สนับสนุนผู้คลอด	ต้องแปลงเป็นแนวทางบริการและฝึกภายใต้สิทธิ [S04]
หลังคลอด	WHO 2022: ดูแลแม่/ทารก สุขภาพจิต ความพร้อมครอบครัว ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์แรก	มีเนื้อหาสำหรับพ่อแม่และทีมรักษา [S05]
ภาวะแทรกซ้อน	WHO/FIGO/ICM 2025: ป้องกัน วินิจฉัย และจัดการตกเลือดหลังคลอด	เนื้อหาคลินิกเฉพาะวิชาชีพ ไม่ใช่คู่มือ DIY [S06]
นมแม่	WHO/UNICEF BFHI 2018: กระบวนการและการสนับสนุนในสถานบริการ	การจัดคลาสไม่พิสูจน์ว่าโรงพยาบาลได้รับการประเมิน BFHI [S07]

3.3 หลักฐานประสิทธิผลของ continuity of care

Cochrane Review 2024 รวม 17 การทดลอง สตรี 18,533 คน: เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น การดูแลต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์มีแนวโน้มเพิ่มการคลอดทางช่องคลอดเอง และลดการฝาคลอดเล็กน้อย (RR ของการฝาคลอด 0.91, 95% CI 0.84–0.99) แต่การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รวมครรภ์เสี่ยงสูง จึงไม่ควรใช้ผลแทนการพิจารณาสถานการณ์ของผู้ป่วยทุกกลุ่ม [S08]

บทเรียนสำหรับผู้ทำหลักสูตร: การวัดผลควรมีการสื่อสาร การจัดลำดับความเสี่ยง การตัดสินใจร่วม และความถูกต้องของการส่งต่อ นอกเหนือจากการจำเนื้อหา

4 | การผดุงครรภ์ไทยและพื้นบ้าน: ความรู้กับความปลอดภัย

4.1 เนื้อหาองค์ความรู้

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่ตรวจพบมีวิชาผดุงครรภ์ไทย อ้างอิงหลักคิด คัมภีร์ และพิธีกรรม/กิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้งหลักการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด การแยกภาวะผิดปกติ และการส่งต่อ [S15,S16]

กิจกรรม/กลุ่มความรู้	บริบทที่พบ	หลักการประเมินก่อนเผยแพร่
นวดและประคบสมุนไพร	การฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอดตามบริบทไทย	ตรวจช่วงเวลา ข้อห้าม แผลผ่าคลอด ความร้อน ผู้ให้บริการ
อยู่ไฟ/อบสมุนไพร/ทับหม้อเกลือ	ความรู้และวิถีการดูแลหลังคลอด	ประเมินความเสี่ยงความร้อน ไหม้ ขาดน้ำ ความดัน และข้อจำกัด
สมุนไพรรับประทาน	ตำรับตามความเชื่อและสถาบันฝึก	ตรวจส่วนประกอบ ปฏิกิริยาระหว่างยา และข้อห้ามเฉพาะตำรับ
ภูมิปัญญาหมอตำแย	บริบททางวัฒนธรรม การถ่ายทอดในชุมชน	ไม่สรุปว่าผู้สืบทอดมีใบอนุญาตหรือมีสิทธิทำคลอด
การค้นพบความผิดปกติ/ส่งต่อ	ส่วนที่ควรบูรณาการเข้าระบบปัจจุบัน	เกณฑ์หยุดบริการ บทบาทใครส่งต่อ และบันทึกข้อมูล

4.2 หลักฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ

งานทบทวนเชิงสำรวจใน Journal of Health Science of Thailand ปี ๒๐๒๕ ศึกษาผู้ให้บริการจากสถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก ๑๐๑ แห่ง รายงานการใช้กิจกรรม เช่น นวด/ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และทับหม้อเกลือ อย่างไรก็ตาม การสำรวจความแพร่หลายของการปฏิบัติไม่ได้ยืนยันประสิทธิผลหรือความปลอดภัยของทุกกิจกรรม [S22]

ตัวอย่างความปลอดภัยเชิงตำรับ: ฐานข้อมูลกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุข้อห้ามของประสะไพลสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ตกเลือดหลังคลอด ข้อมูลนี้เป็นตัวอย่างว่า “สมุนไพร” ต้องประเมินตามตำรับและภาวะผู้ป่วย ไม่ควรเหมารวมว่าปลอดภัย [S23]

4.3 การบูรณาการที่เหมาะสม

คู่มือผดุงครรภ์ไทยแบบบูรณาการของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการออกแบบบริการร่วมกับทีมสุขภาพ อย่างไรก็ดี ก่อนนำไปเป็น SOP ของสถานบริการ ต้องเปิดอ่านฉบับเต็มและให้ผู้รับผิดชอบวิชาชีพรับรองข้อปฏิบัติจริง [S19]

ห้ามใช้เนื้อหาสมุนไพร การประคบร้อน หรือหัตถการเป็นคำแนะนำปฏิบัติเองแก่หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดที่มีอาการเสี่ยง ต้องตรวจภาวะทางการแพทย์และผู้ให้บริการที่มีสิทธิก่อนทุกครั้ง

5 | หลักสูตรวิชาชีพที่พบในประเทศไทย (2569)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็น “ตัวอย่างที่ตรวจพบจากหน้าเจ้าของหลักสูตร/หน่วยงาน” มิใช่รายชื่อครบทุกสถาบัน และมิใช่การยืนยันว่าทุกรอบยังเปิดสมัคร ณ วันนี้

เส้นทาง/ตัวอย่าง	เวลา–โครงสร้างที่เผยแพร่	สถานะข้อมูล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรมีการเรียนทฤษฎีและฝึกคลินิกในวิชาการพยาบาล/ผดุงครรภ์	สภาการพยาบาลมีเกณฑ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2568; ตรวจรายชื่อสถาบัน/หลักสูตร [S09,S10,S37]
ป.โท การผดุงครรภ์ ม.บูรพา	หลักสูตรปรับปรุง 2566; 36 หน่วยกิต	เผยแพร่โครงสร้างและการให้ความเห็นชอบ [S12]
ป.โท การผดุงครรภ์ ม.มหาสารคาม	หลักสูตรปรับปรุง 2568	พบในหน้ารายการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา; ตรวจรอบรับสมัครแยก [S38]
เฉพาะทาง การผดุงครรภ์ มช. รุ่น 2	1 ก.พ.–30 พ.ค. 2570; รับสมัครถึง 13 พ.ย. 2569; ค่าอบรมที่ประกาศ 55,000 บาท	ประกาศรับสมัครสำหรับผู้มีใบอนุญาตวิชาชีพ [S13]
เฉพาะทาง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มหิดล	หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง	พบคำอธิบายหลักสูตร; ไม่ยืนยันว่ารับสมัครรอบปัจจุบัน [S14]
พท.บ. ม.ราชภัฏอุดรธานี	หลักสูตรปรับปรุง 2569; วิชาผดุงครรภ์ไทย 1–2	รายละเอียดรายวิชาในเอกสารหลักสูตร [S15]
พท.บ. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น	หลักสูตรปรับปรุง 2568; 4 ปี 138 หน่วยกิต; มีฝึกผดุงครรภ์ไทย	ข้อมูลหน้าเจ้าของหลักสูตร [S16]
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ไทย ม.ปทุมธานี	1 ปี: ทฤษฎี 120 ชม. ปฏิบัติ 80 ชม. ฝึกประสบการณ์ 200 ชม.	หน้าเจ้าของหลักสูตร; ต้องสอบ/ขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนด ไม่เกิดสิทธิอัตโนมัติ [S17]
อบรมผดุงครรภ์ไทยสำหรับพยาบาล	62 ชั่วโมง (กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยแพร่ มิ.ย.2569)	อบรมเพิ่มเติม ไม่เทียบเท่าการมีใบอนุญาตใหม่ [S18]

คำถามตรวจสอบก่อนสมัคร/นำหลักสูตรมาใช้

- สถาบันและรุ่นนี้ได้รับการรับรองหรือให้ความเห็นชอบจากใคร เมื่อไร ครอบคลุมรุ่นปีใด?
- คุณสมบัติผู้เรียนต้องมีใบอนุญาตเดิมหรือประสบการณ์วิชาชีพหรือไม่?
- ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ฝึกปฏิบัติ และการประเมินทักษะกำหนดอย่างไร?
- หลังเรียนได้รับ “วุฒิ/ประกาศนียบัตร” หรือมีสิทธิสอบใบอนุญาตแยก?
- ประกาศหลักสูตรเก่ากับประกาศ “เปิดรับสมัครรอบใหม่” ตรงกันหรือไม่?

6 | โรงเรียนพ่อแม่: โรงพยาบาลสอนอะไรจริง

ตารางนี้แยก “รายการกิจกรรมของโรงพยาบาล” ออกจาก “แนวทางวิชาการอ้างอิง” อย่างเคร่งครัด: ข้อมูลรายการกิจกรรมอ้างจากเว็บโรงพยาบาลหรือ UNICEF ไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลนั้นอ้างหรือได้รับการรับรอง WHO/UNICEF เป็นรายหลักสูตร

หน่วยบริการ	สิ่งที่มีหลักฐานเผยแพร่	ข้อจำกัดของหลักฐาน
รพ.อ่างทอง (รัฐ)	UNICEF รายงานโรงเรียนพ่อแม่ทุกบ่าย ศุกร์ ณ ส.ค. 2568: ระดับ 1 อายุครรภ์ <28 สัปดาห์; ระดับ 2 ที่ 28–32 สัปดาห์; เน้นเตรียมคลอด/นมแม่ [S27]	ตารางเวลาเป็นข้อมูล ณ วันที่บทความเผยแพร่ ไม่ยืนยันทุกสัปดาห์ใน 2569
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ มช.	บริการเตรียมคลอด การหายใจ/ผ่อนคลาย บทบาทครอบครัว ท่าทาง การเตรียมให้นม; พบโปรแกรมผสมกับการออกกำลังกาย [S28]	หน้าเว็บประกาศบริการ ราคาหรือเงื่อนไขอาจเปลี่ยน
สมิติเวช สุขุมวิท	หน้าโรงพยาบาลระบุอบรมมารดาก่อนคลอดเรื่องนมแม่เป็นประจำทุกเดือนโดยไม่มีค่าบริการเพิ่ม [S29]	ไม่พบ syllabus รายคาบครบทุกกิจกรรมบนหน้าดังกล่าว
บำรุงราษฎร์	หน้าบริการคลอดระบุมีคลาสเตรียมคลอดสำหรับพ่อแม่มือใหม่และคำแนะนำรายบุคคล [S30]	ไม่ได้ระบุรอบ/วัตถุประสงค์รายบทครบ
รพ.ซีจีเอช ลำลูกกา	กิจกรรม Mother Class วันที่ 6 มิ.ย. 2569 มีบทเรียนการดูแลตั้งครรภ์/เตรียมคลอดและดูแลทารก [S31]	หลักฐานของกิจกรรมที่จัด ไม่ยืนยันว่าเปิดอย่างต่อเนื่อง
รพ.ศรีสวรรค์ นครสวรรค์	Mother Class วันที่ 24 ต.ค. 2569 มี Doctor Talk เรื่องอัลตราซาวด์ โยคะคนท้อง และเตรียมคลอด [S32]	เป็นข่าวกิจกรรมเฉพาะครั้งล่าสุด
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์	Mother Class ครั้งที่ 5 ปี 2569 ดูแลแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เตรียมคลอดและทารกแรกเกิด [S33]	ไม่พบตารางวัดผลการเรียนรายหัวข้อ

รูปแบบการสอนที่พบร่วมกัน

อธิบายด้วยแพทย์/พยาบาล → ทำกิจกรรมหรือ Workshop (เช่น ทารกแรกเกิด การหายใจ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม) → ฝึกผู้ดูแล/คู่สมรส → เปิดโอกาสถามตอบ → ให้ช่องทางปรึกษาหลังกลับบ้าน ตัวอย่างนี้เป็นการสังเคราะห์จากหลายบริการ ไม่ใช่ syllabus เดียวที่ทุกโรงพยาบาลใช้ [S27–S33]

7 | โรงเรียนพ่อแม่ “อ้างอิงจากอะไร”

7.1 เอกสารไทยที่ใช้เป็นฐานออกแบบ

กรมอนามัยเผยแพร่ชุด “คู่มือโรงเรียนพ่อแม่” จำนวน 9 เล่ม แยกเป็นไตรมาส 1 (1–12 สัปดาห์), ไตรมาส 2 (13–27), ไตรมาส 3 (28–40), หลังคลอด, ทารกแรกเกิด–4 เดือน, 5–8, 9–12, 13–18 และ 19–24 เดือน [S24,S25,S39,S40]

ตัวอย่างเอกสาร “คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก” ที่เผยแพร่ผ่านหน่วยงานรัฐ จัดการสอนโรงเรียนพ่อแม่ไว้ในคลินิก ANC, PP และ WBC และกำหนด 5 หัวข้อระหว่างตั้งครรภ์ / 4 หัวข้อหลังคลอด / 4 หัวข้อคลินิกเด็กดี ทั้งนี้ต้องตรวจสอบประกาศฉบับล่าสุดก่อนใช้เป็นเกณฑ์บังคับหรือ KPI ปัจจุบัน [S26]

ระยะ **ANC: 5** เรื่อง	ระยะ **PP: 4** เรื่อง	**WBC: 4** เรื่อง
การใช้สมุดบันทึกสุขภาพ	การปฏิบัติตัวหลังคลอด	นมแม่อย่างยั่งยืน
อาหารของแม่เพื่อลูก	อาบน้ำและนวดสัมผัสทารก	เริ่มอาหารตามวัย
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน	การเล่น/เล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการ	สร้างวินัยให้ลูก
นมแม่	นมแม่: แม่ทำได้	เตรียมลูกสู่โลกกว้าง
ทันตสุขภาพ	—	—

7.2 เทียบกรอบไทยกับสากล

แหล่งอ้างอิง	ใช้สนับสนุนเรื่องใด	สิ่งที่ยืนยันไม่ได้
กรมอนามัย [S24–S26]	สาระการเรียนรู้แม่/ลูก และตัวอย่างแผนการสอนในไทย	ไม่ได้ยืนยันทุกโรงพยาบาลใช้คาบหรือเกณฑ์เหมือนกัน
WHO ANC/คลอด/หลังคลอด [S03–S05]	มาตรฐานการสื่อสาร การประเมิน และประสบการณ์การดูแล	ไม่ใช่หนังสืออนุมัติคลาสโรงพยาบาลรายแห่ง
WHO/UNICEF BFHI [S07]	ระบบสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	สอนนมแม่ ≠ ได้รับสถานะ Baby-friendly โดยอัตโนมัติ
ICM [S01,S02]	สมรรถนะสำหรับการศึกษาผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ	ไม่ใช่หลักสูตรใบประกาศโรงเรียนพ่อแม่
เว็บโรงพยาบาล [S27–S33]	ยืนยันว่า “สถานที่นี้ระบุว่ามีกิจกรรมใด”	ไม่เพียงพอระบุการรับรองมาตรฐาน/ผลลัพธ์คลินิก

8 | ข้อเสนอ: หลักสูตรพ่อแม่ฉบับนำไปใช้ได้

ส่วนนี้เป็น “ข้อเสนอของผู้จัดทำ” ที่สังเคราะห์จากเอกสาร ไม่ใช่ตารางเรียนที่โรงพยาบาลใดประกาศใช้อยู่จริง

โมดูล	เนื้อหาหลัก	กิจกรรมที่วัดผลได้
M1 วางแผนครอบครัว/ANC	เส้นทางฝากครรภ์ สมุดสุขภาพ คำถามในนัดแพทย์	อธิบายแผนติดตามครรภ์ได้
M2 โภชนาการและการเปลี่ยนแปลง	อาหาร การออกกำลังกาย ความเครียด ยา/สมุนไพร	แยกสิ่งที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
M3 อาการผิดปกติ	สัญญาณอันตรายแม่/ทารก การติดต่อฉุกเฉิน	เลือกสถานการณ์ที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล
M4 แผนคลอดและสิทธิ	ทางเลือกคลอด สื่อสารความต้องการ บทบาทคู่สมรส	ออกแบบแผนคลอดและขอความยินยอม
M5 ทักษะก่อนคลอด	ผ่อนคลาย หายใจ เคลื่อนไหวตามที่บุคลากรประเมิน	ซ้อมกับผู้สอนอย่างปลอดภัย
M6 หลังคลอดและสุขภาพจิต	การฟื้นตัว สนับสนุนทางใจ การนัดติดตาม	บอกอาการที่ต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
M7 นมแม่และการขอความช่วยเหลือ	พื้นฐานการให้นม ปัญหาพบบ่อย การส่งต่อปรึกษา	ระบุจุดช่วยเหลือและแนวทางปรึกษา
M8 ดูแลทารกแรกเกิด	สัมผัส อาบน้ำปลอดภัย การนอน สุขอนามัย วัคซีน	ฝึกกับหุ่น/สื่อและตอบคำถามความปลอดภัย

เกณฑ์ประเมินที่เสนอ

- ก่อน/หลังเรียน: ความเข้าใจสถานการณ์ ไม่ใช่ท่องจำข้อเท็จจริง
- Skill station: ฝึกกับหุ่นเด็ก อธิบายลำดับการเตรียมเครื่องใช้และขอความช่วยเหลือ
- Scenario: พบสัญญาณเสี่ยงแล้วตัดสินใจติดต่อบริการสุขภาพได้ถูกต้อง
- การเข้าถึง: คู่สมรส/ผู้ดูแลร่วมเรียนได้ มีสื่อภาษาเข้าใจง่ายและติดตามหลังกลับบ้าน
- ตัวชี้วัด: ความถูกต้องการตัดสินใจ, self-efficacy, ความพึงพอใจและการเชื่อมโยงบริการ ไม่ยืนยันผลลัพธ์สุขภาพโดยไม่มีข้อมูลวิจัย

9 | ข้อเสนอ: โครงสร้าง Knowledge Base แบบตรวจสอบย้อนกลับได้

เริ่มจาก “หนึ่งเรื่อง = หนึ่งหน่วยความรู้” แทนการนำ PDF ขนาดใหญ่เข้า RAG โดยไม่มี metadata แล้วใช้ระบบ versioning เพื่อกันการนำมาตรฐานที่ถูกแทนที่กลับมาอ้าง

Field	ตัวอย่างการเก็บ
knowledge_id / title	KB-ANC-001 / การเตรียมคลอด: สัญญาณควรขอความช่วยเหลือ
audience / scope	parent / nursing_student / licensed_professional
care_stage	preconception / ANC / intrapartum / postpartum / newborn
learning_objective	ระบุ 3 สถานการณ์ที่ต้องขอความช่วยเหลือได้
content_type	law / guideline / curriculum / hospital_program / research / proposal
citation + publication_year	S05 / WHO / 2022 / URL / หน้าอ้างอิง
evidence_status	verified_primary / secondary / synthesis / proposed / needs_review
jurisdiction + profession	Thailand / nursing-midwifery หรือ Thai traditional medicine
contraindication / escalation	กรณีห้ามใช้, จุดหยุดบริการ, หน่วยส่งต่อ
reviewer + version	ผู้เชี่ยวชาญผู้อนุมัติ / วันที่ทบทวน / history
status + expiry	active / under_review / superseded; รอบตรวจซ้ำ
original_quote_locator	เลขหน้า/หัวข้อเอกสารต้นฉบับเพื่อ audit

ตัวอย่างบันทึก 1 รายการ

KB-PP-001 | หัวข้อ: สัญญาณอันตรายในช่วงหลังคลอด | เป้าหมาย: ผู้ปกครองบอกได้ว่าเลือดออกมากผิดปกติ/เจ็บหน้าอก/หายใจลำบากต้องขอความช่วยเหลือทันที | ฐานหลักฐาน: WHO 2025 [S36] | ขอบเขต: การรู้ทันและการส่งต่อ ไม่สอนรักษาเอง | สถานะ: draft ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไทยตรวจและ map ช่องทางบริการก่อนเผยแพร่

ข้อเสนอ workflow การนำเข้าความรู้

- รวบรวมต้นฉบับและบันทึก URL / วันที่เข้าถึง / ประเภทเอกสาร
- แยกข้อเท็จจริง (Fact) กับข้อเสนอออกจากกัน และผูกข้อความกับแหล่งอ้างอิง
- ผู้ทบทวนเชี่ยวชาญตรวจขอบเขตวิชาชีพ ข้อห้าม และปีมาตรฐาน
- แบ่งเนื้อหาประชาชนออกจากหัตถการหรือการจัดการฉุกเฉินสำหรับผู้มีใบอนุญาต
- กำหนดการทดสอบความรู้และ scenario-based evaluation พร้อม audit log
- ทบทวนตามรอบ 6 1 2 เดือน (ข้อเสนอบริหารข้อมูล) และทันทีเมื่อมาตรฐานเปลี่ยน

10 | ออกแบบการเรียนด้วยสถานการณ์จำลอง (ข้อเสนอ)

หากจะนำ Knowledge Base นี้ไปสร้างระบบฝึกตัดสินใจหรือ AI virtual patient ให้เลือกสถานการณ์ที่เน้น “ประเมินความเสี่ยง–สื่อสาร–หยุดและส่งต่อ” มากกว่าฝึกหัตถการโดยไม่มีผู้กำกับ พร้อมแสดงระดับสิทธิของผู้เรียนชัดเจน

ฉากจำลอง	สมรรถนะที่ฝึก	จุดประเมิน
หญิงหลังคลอดต้องการรับบริการฟื้นฟูแบบไทย แต่รายงานเลือดออกผิดปกติ	ซักถามความเสี่ยงและตัดสินใจหยุดบริการ	ตระหนัก red flag และส่งต่อเร่งด่วน [S06,S36]
ผู้ปกครองกังวลว่าทารกดูดนมไม่ดีและซึมลง	สื่อสารด้วยภาษาง่ายและประเมินความจำเป็นของการช่วยเหลือ	ไม่ชะลอการประเมินโดยบุคลากร [S35]
ผู้รับบริการขอใช้สมุนไพรหลังคลอดที่มีข้อห้ามในบางกลุ่ม	แยกความเชื่อ/ข้อเท็จจริงและตรวจข้อจำกัด	ไม่รับรองความปลอดภัยจากคำว่า “ธรรมชาติ” [S23]
ผู้คลอดมีคำถามเกี่ยวกับทางเลือกการคลอด	เคารพสิทธิและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	ไม่บังคับ/ไม่บิดเบือนข้อมูล [S04]
คู่สมรสต้องเตรียมของและแผนเดินทางเมื่อใกล้คลอด	เตรียมพร้อมสื่อสารและประสานผู้ดูแล	มีแผนฉุกเฉินและรู้ช่องทางบริการ [S24]

กรอบการให้คะแนนที่เสนอ

มิติ	น้ำหนักตัวอย่าง	พฤติกรรมที่ต้องพบ
Recognize Red Flags	35%	สังเกตข้อมูลสำคัญ/ไม่ละเลยภาวะเสี่ยง
Safe Decision / Referral	30%	ตัดสินใจหยุด-ส่งต่ออย่างเหมาะสม
Communication & Respect	20%	ถามด้วยความเคารพ ให้ข้อมูลและยินยอม
Evidence & Scope	15%	ไม่ล้ำขอบเขตวิชาชีพ อ้างข้อจำกัด

คะแนนเป็นตัวอย่างออกแบบ ไม่ใช่แบบประเมินที่ได้รับการรับรอง ต้องทดสอบกับอาจารย์/ผู้ประกอบวิชาชีพและใช้ตัวอย่างผู้ป่วยสมมติเท่านั้น

11 | ช่องว่างข้อมูลและสิ่งที่ต้องตรวจยืนยัน

ประเด็น	พบแล้ว	ยังยืนยันไม่ได้
มาตรฐานสากล	มี WHO, ICM, BFHI, Cochrane ฉบับระบุปี [S01–S08]	โรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้ guideline version ใดจริง
หลักสูตรวิชาชีพ	มีเกณฑ์สภา/หลักสูตรตัวอย่างจากสถาบัน [S09–S18]	ความครบถ้วนทุกสถาบันและทุกปีรับสมัคร
ผดุงครรภ์ไทย	มีหลักสูตรและคู่มือกรมฯ ปี 2569 [S15–S23]	การรับรองรายคน ขอบเขตหัตถการในหน้างานเฉพาะแห่ง
โรงเรียนฟอแม่	มีคู่มือกรมอนามัยและตัวอย่างโรงพยาบาล [S24–S33]	การวัดผล ทะเบียนชั้นเรียน อัตราสำเร็จ และแหล่งอ้างอิงในเอกสารภายใน
งานวิจัยภูมิปัญญา	มีผลสำรวจการปฏิบัติ 101 โรงพยาบาล [S22]	ประสิทธิผลเฉพาะกิจกรรมทุกชนิดและความปลอดภัยทุกกลุ่ม
ข้อมูลค่าลงทะเบียน/รอบสอน	มีราคาหรือวันที่ประกาศบางแห่ง [S13,S28]	ข้อมูล ณ วันสมัครจริงอาจเปลี่ยน

รายการคำถามสำหรับสอบถามโรงพยาบาล

7 . มีหลักสูตรฉบับปัจจุบัน (syllabus) และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ดูหรือไม่?

8 . กลุ่มเป้าหมายและจำนวนครั้งเรียน/เวลาเรียนเท่าใด มีการแบ่งตามไตรมาสหรือไม่?

9 . หัวข้อและสื่อใดอ้างคู่มือกรมอนามัย, WHO, BFHI หรือ protocol ภายในองค์กร? ขอชื่อ/ปีฉบับได้หรือไม่?

10 . มี Workshop อาบน้ำเด็ก เช้าเต้า การหายใจ และการรับมือ red flags อย่างไร?

11 . มี pre/post-test, skill checklist และการประเมินหลังกลับบ้านหรือไม่?

12 . ผู้สอนเป็นใคร วิธีส่งต่อคนมีความเสี่ยงไปยังทีมสูติกรรมและกุมารเวชอย่างไร?

13 . มีหลักฐานได้รับการประเมิน BFHI หรือมาตรฐานใด “จริง” หรือเป็นเพียงการใช้หลักการประกอบการสอน?

ข้อสรุปสุดท้าย

หากต้องการสร้าง Knowledge Base ที่นำไปใช้ได้จริง ให้เริ่มที่คู่มือกรมอนามัยสำหรับฟอแม่ ผนวกกรอบสมรรถนะ ICM/แนวทาง WHO สำหรับบุคลากร และเพิ่มชั้นองค์ความรู้ผดุงครรภ์ไทยโดยผูกข้อห้าม/สิทธิวิชาชีพกับแต่ละการกระทำ หลักการที่ต้องยึดคือ “ตรวจย้อนกลับได้ ปลอดภัย และไม่สับสนระหว่างความรู้กับใบอนุญาต”

เอกสารอ้างอิงและลิงก์ต้นฉบับ

รูปแบบ: [รหัส□ ชื่อแหล่ง — หน่วยงาน | กดเปิดหน้าเว็บ / PDF ต้นฉบับ รายการ URL ฉบับเต็มมีในไฟล์ Source_Index.md ที่แนบเพิ่มเติม

[S01] ICM Essential Competencies for Midwifery Practice (2024)
International Confederation of Midwives • มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระหว่างประเทศ • เปิดต้นฉบับ

[S02] ICM: Using the Essential Competencies in a Midwifery Curriculum
International Confederation of Midwives • แนวทางออกแบบหลักสูตรตามสมรรถนะ • เปิดต้นฉบับ

[S03] WHO: Antenatal care guideline / 8 contacts (2016)
World Health Organization • มาตรฐานดูแลระหว่างตั้งครรภ์ • เปิดต้นฉบับ

[S04] WHO recommendations: Intrapartum care (2018)
World Health Organization • การดูแลระยะคลอดแบบยึดผู้คลอดเป็นศูนย์กลาง • เปิดต้นฉบับ

[S05] WHO recommendations: Postnatal care (2022)
World Health Organization • มาตรฐานดูแลมารดาและทารกหลังคลอด • เปิดต้นฉบับ

[S06] WHO–FIGO–ICM: Postpartum haemorrhage guideline (2025)
WHO / FIGO / ICM • แนวทางภาวะตกเลือดหลังคลอดสำหรับบุคลากร • เปิดต้นฉบับ

[S07] WHO / UNICEF: Revised Baby-friendly Hospital Initiative (2018)
WHO / UNICEF • มาตรฐานการสนับสนุนการให้นมแม่ในสถานบริการ • เปิดต้นฉบับ

[S08] Cochrane review on midwife continuity of care (2024)
Cochrane / PubMed • หลักฐานวิจัย RCT 17 การศึกษา 18,533 คน • เปิดต้นฉบับ

[S09] แนวทางให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2568
สภาการพยาบาล • กรอบกำกับหลักสูตรปริญญาตรี • เปิดต้นฉบับ

[S10] การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล • การตรวจสอบการรับรองสถาบัน • เปิดต้นฉบับ

[S11] กำหนดการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ ปี 2569
สภาการพยาบาล • การขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต • เปิดต้นฉบับ

[S12] หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ (ปรับปรุง 2566)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา • ตัวอย่างปริญญาโท ≥36 หน่วยกิต • เปิดต้นฉบับ

[S13] หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ • ตัวอย่างหลักสูตรบุคลากรและประกาศรับสมัคร 2570 • เปิดต้นฉบับ

[S14] หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล • ตัวอย่างการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง • เปิดต้นฉบับ

[S15] หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ. 2569
ม.ราชภัฏอุดรธานี • ตัวอย่างผดุงครรภ์ไทยในปริญญาตรี • เปิดต้นฉบับ

[S16] หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ปรับปรุง 2568)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น • ตัวอย่าง 4 ปี 138 หน่วยกิต • เปิดต้นฉบับ

[S17] หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี • ตัวอย่างหลักสูตร 1 ปี แยกใบอนุญาต • เปิดต้นฉบับ

[S18] หลักสูตรผดุงครรภ์ไทยสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 62 ชั่วโมง (2569)
กรมการแพทย์แผนไทยฯ • หลักสูตรอบรมเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ • เปิดต้นฉบับ

[S19] คู่มือจัดบริการผดุงครรภ์ไทยแบบบูรณาการ (2569)
กรมการแพทย์แผนไทยฯ • คู่มือบริการและบูรณาการ • เปิดต้นฉบับ

[S20] พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
รวบรวมกฎหมาย / อ้างถึงราชกิจจานุเบกษา • ถ้อยคำกฎหมาย—ควรตรวจสอบประกาศต้นฉบับก่อนใช้นิติการ • เปิดต้นฉบับ

[S21] จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557
ราชกิจจานุเบกษา • ข้อกำหนดจริยธรรมและความปลอดภัย • เปิดต้นฉบับ

[S22] Review of Thai Traditional Principles of Postpartum Care (2025)
Journal of Health Science of Thailand • การสำรวจแนวปฏิบัติ 101 สถานพยาบาล—ไม่ใช่ผลการรักษา • เปิดต้นฉบับ

[S23] คลังข้อมูลยาสมุนไพร: ข้อห้ามของตำรับประสะไพล
กรมการแพทย์แผนไทยฯ • ตัวอย่างข้อห้ามที่ต้องตรวจสอบแยกตำรับ • เปิดต้นฉบับ

[S24] คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ 9 เล่ม (หน้ารวมและตัวอย่างเล่ม 1)
กรมอนามัย • สื่อการเรียนรู้ตามช่วงอายุครรภ์และเด็ก • เปิดต้นฉบับ

[S25] คู่มือโรงเรียนพ่อแม่: หลังคลอด
กรมอนามัย • การปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอด • เปิดต้นฉบับ

[S26] คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก: โรงเรียนพ่อแม่
ชุดเอกสารสาธารณะที่เผยแพร่ผ่านหน่วยงานรัฐ • ตัวอย่างโครงสร้าง 5/4/4 หัวข้อ ไม่ยืนยันสถานะบังคับใช้ล่าสุด • เปิดต้นฉบับ

[S27] โรงเรียนพ่อแม่ โรงพยาบาลอ่างทอง (2025)
UNICEF Thailand • ตัวอย่างในโรงพยาบาลรัฐ • เปิดต้นฉบับ

[S28] โปรแกรมเตรียมคลอดและครอบครัว
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มช. • ตัวอย่างบริการเชิงปฏิบัติการ พร้อมคำอธิบายและราคา • เปิดต้นฉบับ

[S29] สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่—อบรมก่อนคลอด
โรงพยาบาลสมิติเวช • อบรมด้านนมแม่ก่อนคลอด • เปิดต้นฉบับ

[S30] บริการคลอดและคลาสเตรียมคลอด
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ • ยืนยันว่ามีคลาส แต่ไม่ได้แจก syllabus ครบ • เปิดต้นฉบับ

[S31] Mother Class ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2569
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา • หลักฐานกิจกรรมปี 2569 • เปิดต้นฉบับ

[S32] Mother Class: Mom Power วันที่ 24 ตุลาคม 2569
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ • กิจกรรมล่าสุดก่อนวันตรวจสอบ • เปิดต้นฉบับ

[S33] Mother Class ปี 2569
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ • กิจกรรมในโรงพยาบาลเอกชน • เปิดต้นฉบับ

[S34] โรงเรียนพ่อแม่: การเตรียมคลอดและดูแลหลังคลอด
WHO health information • การรับบริการและสัญญาณอันตรายหลังคลอด • เปิดต้นฉบับ

[S35] WHO: Care of the newborn
World Health Organization • ฐานความรู้การดูแลทารก • เปิดต้นฉบับ

[S36] WHO: Postpartum warning signs (2025)
World Health Organization • สัญญาณอันตรายทั่วไปของแม่และทารก • เปิดต้นฉบับ

[S37] สภาการพยาบาล หลักสูตรปริญญาตรี
สภาการพยาบาล • จุดตรวจสอบรายการหลักสูตรปริญญาตรี • เปิดต้นฉบับ

[S38] หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ (ปรับปรุง 2568)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • อีกตัวอย่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา • เปิดต้นฉบับ

[S39] หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ ไตรมาส 2
กรมอนามัย • คู่มือไตรมาส 2 • เปิดต้นฉบับ

[S40] หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ ไตรมาส 3
กรมอนามัย • คู่มือไตรมาส 3 • เปิดต้นฉบับ